

LISA-DIGITAL

bereitgestellt über CareInsight

Umfassende Patientenverfügung

Medizinische Behandlungswünsche gemäß § 1827 BGB

UMFASSENDE MEDIZINISCHE PATIENTENVERFÜGUNG

Gemäß § 1827 BGB mit detaillierten intensivmedizinischen und pflegerischen Handlungsanweisungen

1. Personalien und Geltungsbereich

Name, Vorname:

Geburtsdatum und -ort:

Wohnhaft in (Anschrift):

Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Nach reiflicher Überlegung, frei von äußeren Zwängen und in Kenntnis der medizinischen und juristischen Tragweite meiner Entscheidungen, bestimme ich hiermit im Voraus, welche medizinischen, pflegerischen und palliativen Maßnahmen bei mir durchgeführt, unterlassen oder abgebrochen werden sollen. Diese Verfügung tritt in Kraft, sobald ich aufgrund von Krankheit, Unfall oder altersbedingtem Abbau nicht mehr in der Lage bin, meinen eigenen Willen zu bilden oder verständlich zu äußern.

Diese Verfügung ist als verbindliche Handlungsanweisung für alle behandelnden Ärzte (Hausärzte, Notärzte, Klinikärzte), das Pflegepersonal sowie meine rechtlichen Betreuer oder Bevollmächtigten zu verstehen. Sollten Ärzte oder Pflegekräfte sich weigern, diesen Willen umzusetzen, weise ich meine Bevollmächtigten an, gerichtliche Schritte einzuleiten und ggf. eine Verlegung zu veranlassen.

2. Werteprofil und Therapieziele (Medizinethische Grundlage)

Für den Fall, dass ärztliche Interpretationsspielräume bei der Umsetzung dieser Verfügung entstehen, definiere ich hier meine grundlegenden Wertvorstellungen als Leitlinie:

- **Lebensqualität vor Lebensdauer:** Ein rein biologisches Überleben, das durch ständige maschinelle Unterstützung erkaufte wird und bei dem eine Interaktion mit meiner Umwelt, Schmerzfreiheit oder ein Bewusstsein ausgeschlossen ist, betrachte ich als unwürdig. In solchen Fällen hat die Linderung von Leid absoluten Vorrang vor der Lebensverlängerung.
- **Zulässigkeit der Lebensverkürzung:** Ich nehme ausdrücklich in Kauf, dass symptomlindernde Maßnahmen (z. B. hochdosierte Opiat- oder Sedativagabe) als unbeabsichtigte Nebenwirkung meine Lebenszeit verkürzen können (sog. indirekte Sterbehilfe).

3. Auslösende klinische Konstellationen (Indikationen)

Die in Abschnitt 4 festgelegten Entscheidungen zu konkreten medizinischen Interventionen treten vollumfänglich und ohne Einschränkung in Kraft, sobald mindestens **eine** der folgenden ärztlich diagnostizierten Situationen vorliegt:

Situation S1: Der unmittelbare Sterbeprozess

Ich befinde mich im unabwendbaren Sterbeprozess. Der Tod ist trotz intensivmedizinischer Maximaltherapie absehbar innerhalb von Stunden bis wenigen Tagen zu erwarten (z. B. infolge von refraktärem kardiogenen oder septischen Schock, Multiorganversagen, schwerstem ARDS).

Situation S2: Terminalstadium einer unheilbaren Erkrankung

Ich befinde mich im Endstadium einer fortgeschrittenen, unheilbaren und letal verlaufenden Erkrankung. Dies umfasst insbesondere, aber nicht ausschließlich:

- Metastasierende, inkurable Tumorerkrankungen.
- Terminale Organinsuffizienzen (z. B. Herzinsuffizienz NYHA IV, COPD GOLD IV, terminale Niereninsuffizienz).
- Fortgeschrittene neurodegenerative Erkrankungen (z. B. ALS im Endstadium, Huntington, fortgeschrittene Parkinson-Krankheit), wenn die Atemmuskulatur oder der Schluckreflex dauerhaft versagen.

Es ist unerheblich, ob der Todeszeitpunkt unmittelbar bevorsteht oder noch Wochen bis Monate entfernt ist.

Situation S3: Schwerste Hirnschädigung ohne Aussicht auf Bewusstseins-erlangung

Als Folge eines hypoxischen Hirnschadens (z. B. nach prolongierter Reanimation), eines schweren Schädel-Hirn-Traumas, einer massiven intrazerebralen Blutung oder eines schweren ischämischen Insults liegt eine schwere, irreversible Hirnschädigung vor. Dies schließt den Zustand des apallischen Syndroms (Wachkoma) ein, wenn nach intensivmedizinischem und neurologischem Standard eine Restitution der kortikalen Funktionen ausgeschlossen ist.

Situation S4: Fortgeschrittener Hirnabbau (Demenzielle Syndrome)

Ich leide an einer weit fortgeschrittenen, irreversiblen Demenz (z. B. Alzheimer, vaskuläre Demenz) oder einer anderen geistigen Verfallserscheinung (entsprechend FAST-Stadium 7 oder GDS-Stadium 7). Typische Merkmale dieses Zustands sind: Ich erkenne meine engsten Angehörigen nicht mehr, die sprachliche Kommunikation ist auf einzelne unartikulierte Laute reduziert, ich bin vollständig pflegebedürftig (Pflegegrad 4 oder 5 nach SGB XI) und die Nahrungsaufnahme auf natürlichem Weg (oral) ist aufgrund von Apraxie oder Dysphagie (Schluckstörung) nicht mehr möglich.

Situation S5: Locked-in-Syndrom oder hohe Querschnittslähmung

Es liegt eine vollständige, irreversible Lähmung der gesamten Skelettmuskulatur vor (z. B. durch Hirnstamminfarkt oder hohe zervikale Querschnittsläsion), die eine dauerhafte (lebenslange) maschinelle Beatmung erfordert. Das Bewusstsein ist zwar erhalten, aber die Fähigkeit zur Interaktion ist minimal und eine eigenständige Lebensführung ist dauerhaft unmöglich.

4. Detaillierte Entscheidungen zu medizinischen Maßnahmen

Tritt eine der unter Abschnitt 3 genannten Situationen (S1 bis S5) ein, ordne ich hinsichtlich der einzelnen medizinischen Maßnahmen verbindlich Folgendes an:

4.1 Kardiopulmonale Reanimation (CPR)	☐ Absolutes Reanimationsverbot (DNR - Do Not Resuscitate): Ich untersage jegliche Versuche der Wiederbelebung. Keine Herzdruckmassage, keine Defibrillation, keine Gabe von Reanimationsmedikamenten. ☐ Bedingter Versuch: Ich wünsche einen einmaligen Reanimationsversuch für maximal _____ Minuten. Kommt es in dieser Zeit nicht zu einer Rückkehr des Spontankreislaufs (ROSC), sind die Maßnahmen abubrechen.
4.2 Atemwegssicherung und maschinelle Beatmung	☐ Intubationsverbot (DNI - Do Not Intubate): Ich untersage die endotracheale Intubation sowie die Anlage eines Tracheostomas. ☐ Abbruch bestehender Beatmung (Terminales Weaning): Sollte ich bereits invasiv beatmet werden, fordere ich die unverzügliche Reduktion und Beendigung der Beatmungstherapie. Vor und während der Extubation ist zwingend eine palliative Abschiirmung sicherzustellen. ☐ NIV (Nicht-invasive Beatmung): Ausschließlich als palliativer Therapieversuch zur Linderung von Atemnot zulässig (Symptomkontrolle), nicht zur reinen Lebensverlängerung.

4.3 Künstliche Ernährung	☐ Verzicht auf künstliche Ernährung: Ich lehne jegliche Form der künstlichen Ernährung ab. Dies umfasst die parenterale Ernährung sowie die enterale Ernährung über Magensonden oder PEG/PEJ-Sonden. ☐ Nahrungsverweigerung bei Demenz (Situation S4): Wenn ich im fortgeschrittenen Demenzstadium die Nahrungsaufnahme auf natürlichem Wege verweigere, ist dies als mein natürlicher Sterbewillen zu respektieren. Niemand darf mich zur Nahrungsaufnahme zwingen. Es ist keine Sonde anzulegen. ☐ Zeitlich befristeter Versuch: Im Falle einer akut reversiblen Komplikation erlaube ich die Anlage einer passageren Magensonde für maximal _____ Tage.
4.4 Flüssigkeitssubstitution (Hydratation)	☐ Verzicht auf künstliche Flüssigkeitszufuhr: Ich untersage die intravenöse oder subkutane Gabe von Flüssigkeit. Mir ist bewusst, dass dies zum Versterben durch Dehydratation führen kann. ☐ Durststillung: Mein Durstgefühl ist ausschließlich pflegerisch durch sorgfältige und regelmäßige Mundpflege zu stillen.
4.5 Dialyse (Nierenersatzverfahren)	☐ Keine Einleitung: Ich untersage die Einleitung einer Hämodialyse, Hämofiltration oder Peritonealdialyse. ☐ Abbruch: Ein bereits laufendes chronisches oder akutes Nierenersatzverfahren ist unverzüglich zu beenden.
4.6 Medikamentöse Therapie und Blutprodukte	☐ Keine Antibiotika: Bei interkurrenten Infektionen lehne ich eine antibiotische Therapie ab, sofern sie das Leben lediglich verlängert. ☐ Keine Kreislaufunterstützung: Ich untersage die Gabe von Vasopressoren und Katecholaminen. ☐ Keine Blutprodukte: Ich untersage die Transfusion von Erythrozyten-, Thrombozytenkonzentraten oder Blutplasma.

5. Palliativmedizinische und pflegerische Begleitung (SGB V / SGB XI)

Sollte eine der unter Abschnitt 3 genannten Situationen eintreten, verlagert sich das primäre Therapieziel von der Kuration/Lebensverlängerung auf die Palliation (Linderung). Hierfür verfüge ich Folgendes:

- **Schmerz- und Symptomkontrolle:** Ich fordere eine konsequente, fachgerechte Schmerztherapie sowie die Behandlung von Atemnot, Übelkeit, Angst und Unruhe gemäß den Leitlinien der Palliativmedizin.
- **Palliative Sedierung:** Sollten refraktäre (anders nicht beherrschbare) Symptome auftreten, fordere ich eine tiefe und kontinuierliche palliative Sedierung bis zu meinem Tod.
- **Pflege (SiS):** Die Grundpflege ist auf mein Wohlbefinden auszurichten. Prophylaxen sind nur durchzuführen, wenn sie meinem aktuellen Wohlbefinden dienen. Schmerzhafter Lagerungsmanöver sind zu unterlassen. Dieser Wille ist in der Pflegedokumentation als primäres Pflegeziel zu verankern.
- **Ort der Versorgung:** Krankenhauseinweisungen sind in der Endphase zwingend zu vermeiden. Ich wünsche, in meiner vertrauten häuslichen Umgebung, einer Pflegeeinrichtung oder einem stationären Hospiz zu versterben. Zur Sicherstellung der ambulanten Symptomkontrolle weise ich meine Ärzte und Angehörigen an, rechtzeitig die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV gem. § 37b SGB V) hinzuzuziehen.

6. Sonderregelungen und Kollisionsvermeidung

6.1 Organspende

☐ **Ausschluss:** Ich lehne eine Organspende ab. Maßnahmen zur Hirntoddiagnostik und organerhaltende Intensivmedizin sind untersagt.

☐ **Zustimmung (Vorrang der Organspende):** Ich stimme einer Organspende zu. Falls die Voraussetzungen für eine Organspende vorliegen, ruhen die unter Abschnitt 4 verfügbaren Ablehnungen lebenserhaltender Maßnahmen für die Dauer der Diagnostik und der Organentnahme.

6.2 Entbindung von der Schweigepflicht (§ 203 StGB)

Hiermit entbinde ich alle mich behandelnden Ärzte und Pflegekräfte vollumfänglich von ihrer gesetzlichen Schweigepflicht gegenüber den Personen, die ich in meiner gesondert verfassten Vorsorgevollmacht benannt habe. Meine Bevollmächtigten haben das uneingeschränkte Recht auf Einsicht in meine Patientenakte.

7. Schlussbestimmungen und Unterschrift

Ich habe den Inhalt dieser Verfügung sorgfältig gelesen, verstanden und in voller Verantwortung für mich selbst getroffen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verfügung aufgrund geänderter Gesetzeslagen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Der Wille zur Begrenzung lebensverlängernder Maßnahmen bei aussichtsloser Prognose ist in jedem Fall maßgeblich.

Ort, Datum: _____

Eigenhändige Unterschrift des Verfassers

(Empfehlung: Notarielle Beglaubigung oder
Hausärztliche Bestätigung optional, jedoch rechtlich nicht
zwingend)

8. Aktualisierung und Bekräftigung (Historie)

Um Ärzten und Richtern zu demonstrieren, dass diese Verfügung meinen dauerhaften und ungebrochenen Willen darstellt, bestätige ich deren Inhalt regelmäßig durch meine Unterschrift. Ein Fehlen dieser Bestätigung macht die Verfügung jedoch **nicht** ungültig.

Datum	Unterschrift zur Bestätigung des ungebrochenen Willens